

＋ 血管外漏出時の対応（抗癌剤以外）＋

血管外漏出を疑う症状

初期症状

滴下速度が遅くなる
滴下しない
血液の逆流が確認できない
違和感
発赤
紅斑
腫脹
疼痛

炎症進行に伴う症状

水疱形成
硬結
潰瘍
壊死

上記症状があり、漏出を疑った場合

直ちに注入を中止し、抜針する

漏出量が少量で問題なければ、
新たに血管ルートを取り再注入

ある程度の量が血管外漏出したと判断したら、直ちに医師へ報告

血管収縮剤（ノルアドレナリン注・ボスミン注・ドパミン塩酸塩など）は、温罨法。

左記の薬剤以外は、漏出した患肢を心臓より上に挙上し、疼痛・腫脹に対しては、冷罨法を実施。1日15分～60分、1日3回、24～72時間を推奨。

疼痛が持続する場合や皮膚障害が発現した場合の処置

消炎鎮痛剤の内服 ジクロフェナクナトリウム等
ステロイド剤の外用あるいは内服
水疱が持続する場合は、穿刺排液

局所所見が完全に消退するまでは
注意深く経過観察

以下の場合、直ちに皮膚科、
形成外科へコンサルテーション

- ①2～4時間後の腫脹や痛みの亢進
- ②組織還流の変化
- ③注射部位上、あるいは遠位での毛細血管再充填時間の延長
- ④感覚の変化
- ⑤皮膚の水疱または潰瘍形成
- ⑥非イオン性造影剤で漏出量が100ml越えるとき